Topografía del abdomen y técnicas de examen

SEMIOLOGIA · Clase 23 · puntos de referencia, 9 regiones, 4 cuadrantes y el orden del examen

1 · PARA QUÉ UN MAPA Y CÓMO SE PREPARA EL EXAMEN

Para qué un mapa
la pared no tiene límites naturales: la región permite describir, comparar y repetir un hallazgo

se concreta con los

exige preparar al paciente en

sirven para trazar

F5
Siete puntos de referencia
ángulo de Charpy (xifoides), rebordes costales, cicatriz umbilical, crestas ilíacas, EIAS, sínfisis del pubis y ligamento inguinal (Poupart)

F9
Condiciones del examen
decúbito dorsal, sin almohada o plana, extremidades extendidas, examinador a la derecha, buena luz y manos tibias

empieza el orden con la

se completa examinando

F9
También de pie y haciendo toser
porque las hernias pequeñas se esconden en decúbito; en la palpación profunda se flexionan las piernas

2 · 9 REGIONES Y 4 CUADRANTES

F6
4 cuadrantes
1 línea xifopubiana y 1 horizontal por el ombligo: división más gruesa y rápida

agrupa lo mismo en

o, más simple, trazar

F6
9 regiones
2 verticales medioclaviculares y 2 horizontales (rebordes costales y EIAS)

delimita

F6
Las 9 regiones
hipocondrios y epigastrio; flancos y mesogastrio; fosas ilíacas e hipogastrio

3 · QUÉ ÓRGANO HAY DEBAJO DE CADA REGIÓN

F1
Cuadrante superior derecho (literatura)
hígado, vesícula, píloro, duodeno proximal y cabeza del páncreas, suprarrenal y parte del riñón derechos, ángulo hepático

F2
Hipocondrio derecho
hígado y vesícula, ángulo hepático del colon, riñón y suprarrenal derechos

arriba a la derecha proyecta

Hipocondrio izquierdo
estómago, bazo, ángulo esplénico, cola del páncreas, riñón y suprarrenal izquierdos

arriba a la izquierda proyecta

Epigastrio
lóbulo hepático izquierdo, estómago, vía biliar, duodeno, aorta y cava

arriba al centro proyecta

a los lados proyecta

F3
Flancos
derecho: colon ascendente; izquierdo: colon descendente (asas de yeyuno e íleon y borde del riñón izquierdo)

al centro proyecta

Mesogastrio
epiplón mayor y colon transverso

abajo a la derecha proyecta

Fosa ilíaca derecha
ciego y apéndice

abajo a la izquierda proyecta

F4
Fosa ilíaca izquierda
sigmoides; en la mujer, ovario y trompa izquierdos (literatura)

abajo al centro proyecta

Hipogastrio
vejiga

por su contenido orienta

La región orienta al órgano: hipocondrio derecho, vesícula; fosa ilíaca derecha, apéndice; epigastrio, úlcera

4 · EL ORDEN DEL EXAMEN: MIRAR, ESCUCHAR, TOCAR, PERCUTIR

F7 · F8
Secuencia abdominal
inspección, auscultación, palpación (superficial y profunda), percusión

primero hace la

Inspección
forma, volumen, piel, ondas, pulsaciones y respiración; de frente y de costado

puede hacerse de forma

luego sigue la

F10
Inspección tangencial (literatura)
ojos a la altura de la pared y luz rasante: abultamientos, ondas peristálticas y pulsaciones

después se pasa a la

Auscultación
diafragma del estetoscopio, antes de tocar

se justifica porque

F7 · F8
Por qué la auscultación se adelanta
palpar o percutir altera los ruidos hidroaéreos

al respetarlo se logra

Respetar el orden conserva el valor de la auscultación

antes de tocar, sigue la

Palpación
superficial con la palma en orden fijo y la zona dolorosa al final; profunda con presión gradual y piernas flexionadas

si la tensión es sostenida

al final viene la

Percusión
vísceras macizas mate, huecas timpánico

5 · NORMAL FRENTE A PATOLÓGICO

Ruidos hidroaéreos normales
moderados, 4 a 5 por minuto (2018: 4 a 6)

normalmente oye

Aumentados y metálicos
peristaltismo de lucha

si los ruidos aumentan

Silencio abdominal
faltan los ruidos: contracciones ineficaces, no parálisis real

si faltan los ruidos

junto con otros hallazgos arma el

Defensa y abdomen en tabla
tensión sostenida de la pared por inflamación peritoneal

por eso orienta a

Signo de Jobert
timpanismo donde debería haber matidez hepática

por eso orienta a

junto con otros hallazgos arma el

por eso orienta a

si son los esperados

junto con otros hallazgos arma el

si no hay matidez hepática

6 · QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER

Orienta a obstrucción mecánica (hernia estrangulada o bridas)

Orienta a íleo paralítico o peritonitis; en el operado es normal 24 a 72 h

Orienta a neumoperitoneo por perforación de víscera hueca

Con 4 a 5 ruidos por minuto y pared depresible el abdomen es normal: se continúa el examen

Abdomen agudo
un hallazgo por técnica: distensión e inmovilidad, tabla, Blumberg, timpanismo y silencio

su combinación orienta a

La suma orienta a peritonitis generalizada o apendicitis complicada: conducta urgente

concepto · técnica · ejemplo · desenlace · mecanismo · signo · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 09b · Sotomayor — teoría del docente (= literatura: cuadrante superior derecho, ovario, inspección tangencial)